

疼痛治疗 考点总结

来源: 第十六章 疼痛治疗.pdf, 共6页

一、核心考点概述

本章内容相对精简，核心考点集中在：2020年IASP疼痛定义更新、四种疼痛评估量表的特点与适应人群、疼痛三种病理生理机制的区分、术后镇痛原则与多模式镇痛、阿片类药物与NSAIDs的用药特点、癌痛WHO三阶梯治疗原则。慢性疼痛分类和微创介入治疗属于次重点。

二、重点概念与定义

- **疼痛 (pain, 2020 IASP定义):** 一种与实际或潜在的组织损伤相关的不愉快的感觉和情绪情感体验，或与此相似的经历 [P1]
- **数字分级评分法 (numerical rating scale, NRS):** 0~10分，0=无痛，1~3=轻度，4~6=中度，7~10=重度；适用于有一定文化程度者 [P1]
- **语言分级评分法 (verbal rating scale, VRS):** 1~5级描述疼痛等级，易受文化程度、方言影响 [P1]
- **视觉模拟评分法 (visual analogue scale, VAS):** 100mm直线，标记疼痛位置；准确简便，临床和科研使用广泛 [P1]
- **修订版Wong-Baker面部表情疼痛评估法 (FPS-R):** 6种面部表情图片，适用于儿童、老年人、文化程度低或表达困难者 [P1]
- **伤害感受性疼痛 (nociceptive pain):** 组织结构损伤所致，炎性刺激因子(P物质、降钙素基因相关肽、谷氨酸、ATP)刺激神经末梢引起 [P2]
- **神经病理性疼痛 (neuropathic pain):** 躯体感觉系统损害或疾病导致的疼痛，机制包括外周敏化、中枢敏化、离子通道改变、下行抑制系统功能降低 [P2]
- **伤害可塑性疼痛 (nociplastic pain):** 中枢神经系统对疼痛和感觉处理的增强以及疼痛调节改变引起，不同于前两类 [P2]
- **外周敏化:** 伤害性感受神经元对传入信号敏感性增加 [P2]
- **中枢敏化:** 脊髓及脊髓以上痛觉相关神经元兴奋性异常升高或突触传递增强 [P2]
- **急性疼痛:** 持续时间通常短于3个月 [P3]
- **慢性疼痛:** 持续时间超过3个月的疼痛，正常组织愈合后仍持续存在 [P4]
- **多模式镇痛 (multimodal analgesia):** 联合不同镇痛机制的药物和技术，采用不同给药途径，作用于疼痛发生的不同部位、时相和靶点 [P3]

- **癌性疼痛 (cancer pain):** 由肿瘤本身以及抗肿瘤治疗过程产生的疼痛 [P6]
- **急性疼痛服务 (acute pain service, APS):** 多学科团队(麻醉医生、手术医生、护士、药师)共同参与疼痛管理 [P3]

三、关键公式与判据

- **NRS分级:** 0=无痛, 1~3=轻度疼痛, 4~6=中度疼痛, 7~10=重度疼痛 [P1]
- **VAS:** 0mm=完全无痛, 100mm=最剧烈疼痛 [P1]
- **WHO三阶梯镇痛基本原则:** "按阶梯给药、口服给药、按时给药、个体化给药和注意具体细节" [P6]
- **术后镇痛目标:** ①最佳镇痛 ②最少不良反应 ③最快速功能恢复 ④最优舒适度和满意度 [P2]

四、分类/分型/分期

4.1 疼痛程度评估量表对比 [P1]

量表	方法	适用人群
NRS	0~10数字自选	有一定文化程度者
VRS	1~5级语言描述	有一定语言理解能力
VAS	100mm直线标记	有抽象思维能力, 科研常用
FPS-R	6种面部表情图	儿童/老年人/表达困难者

4.2 疼痛按病理生理机制分类 [P2]

类型	机制	关键特点
伤害感受性疼痛	组织结构损伤, 炎性因子刺激	外周组织损伤直接引起
神经病理性疼痛	感觉系统损害或疾病	外周敏化+中枢敏化+离子通道改变
伤害可塑性疼痛	中枢对疼痛处理增强	无组织损伤或神经损伤证据

4.3 神经病理性疼痛四大机制 [P2]

1. **外周敏化:** 受损细胞和炎症细胞释放化学物质(去甲肾上腺素、缓激肽、组胺、前列腺素等)→伤害感受器敏化
2. **中枢敏化:** 脊髓及以上神经元兴奋异常升高→自发性疼痛、痛觉过敏、痛觉超敏
3. **离子通道改变:** 钙通道 α_2 - δ 亚基表达升高→钙内流增加→递质释放增加→痛觉过敏

4. 下行抑制系统功能降低: 中枢抑制减弱, 兴奋占主导→疼痛、焦虑、睡眠问题

4.4 术后镇痛方法 [P3]

- 全身给药: 口服(神志清楚、胃肠功能良好)、静脉(起效快)、肌肉注射(现已少用)
- 椎管内麻醉: 适用于胸腹部及下肢术后镇痛
- 外周神经阻滞: 阻断疼痛信号上传
- 局部浸润: 减少术后镇痛药用量

4.5 术后镇痛药物 [P3]

- 阿片类药物: 中重度疼痛的支柱(吗啡、芬太尼、舒芬太尼), 不良反应剂量依赖
- NSAIDs: 轻中度疼痛或重度疼痛辅用; 非选择性(布洛芬等)→胃肠道损伤; COX-2 选择性(依托考昔等)→胃肠道损伤少
- 局麻药: 布比卡因、罗哌卡因, 用于神经阻滞和椎管内
- 右美托咪定: α_2 激动剂, 心动过缓/心脏传导阻滞者慎用或禁用

4.6 慢性疼痛诊治范围(7种) [P4]

1. 慢性原发性疼痛
2. 癌性疼痛
3. 慢性创伤后疼痛
4. 慢性神经病理性疼痛(三叉神经痛、带状疱疹后神经痛、痛性糖尿病周围神经病变等)
5. 慢性头痛和口腔颜面疼痛
6. 慢性内脏性疼痛
7. 慢性肌肉骨骼疼痛(筋膜炎、肩周炎、骨关节炎等)

4.7 微创介入镇痛治疗方法 [P5]

方法	作用机制	适用
神经阻滞	注入药物阻断传导通路	各类神经病理性疼痛
神经射频技术	超高频无线电波切割/神经调节	颈腰椎间盘突出、带状疱疹后神经痛
低温等离子技术	使胶原蛋白转变为液态/气态	椎间盘源性颈肩腰背痛
经皮脊椎内镜	直视下解除神经压迫	脊柱退行性病变
神经调控(SCS/PNS)	电脉冲刺激调节神经功能	带状疱疹后神经痛、周围神经损伤

方法	作用机制	适用
鞘内药物输注(IDDS)	泵入药物至蛛网膜下腔	癌痛及各种难治性疼痛

五、鉴别诊断/对比

5.1 非选择性 vs COX-2选择性NSAIDs [P4]

对比	非选择性(布洛芬等)	COX-2选择性(依托考昔等)
胃肠道损伤	较多	较少
血小板抑制	有	较少
代表药物	布洛芬、酮咯酸、氟比洛芬酯	依托考昔、塞来昔布

5.2 急性疼痛 vs 慢性疼痛 [P3-4]

对比	急性疼痛	慢性疼痛
持续时间	<3个月	>3个月
常见原因	创伤、手术、炎症	组织愈合后持续存在
生物学价值	有(警示作用)	通常没有
主要管理	麻醉科牵头	疼痛科牵头

5.3 术后镇痛三大方案 [P3]

- **多模式镇痛:** 最常用, 联合不同机制药物和技术
- **个体化镇痛:** 综合病人情况、手术部位、创伤面积等
- **规范化镇痛:** APS小组多学科共同参与

六、易错点与技巧

1. **FPS-R量表:** 适用于儿童、老年人、表达困难者——不是VAS! VAS需要抽象思维能力 [P1]
2. **神经病理性疼痛 ≠ 神经痛:** 前者是感觉系统损害所致疾病状态, 有外周敏化/中枢敏化等机制 [P2]
3. **NSAIDs禁忌证:** 消化性溃疡、肾功能不全、出血倾向史、冠脉旁路移植术史 [P5]
4. **对乙酰氨基酚:** 注意肝损伤风险, 慢性疼痛治疗不推荐两种NSAIDs联用 [P5]
5. **阿片类药物:** 术后疼痛支柱, 但不良反应剂量依赖; 慢性疼痛推荐口服给药 [P5]

6. **癌痛三阶梯**: "按阶梯→口服→按时→个体化→注意细节", 阿片类是核心药物 [P6]
7. **右美托咪定**: 术后多模式镇痛常用, 但有心动过缓和呼吸抑制风险 [P3]
8. **PCEA**: 连续中胸段硬膜外病人自控镇痛, 适用于开腹手术, 有低血压/硬膜外血肿/尿潴留风险 [P4 of 围手术期]
9. **术后呼吸抑制处理**: 纳洛酮拮抗阿片类药物过量 [P4]
10. **鞘内药物输注(IDDS)**: 不仅用于癌痛, 也适用于各种难治性疼痛 [P5]
11. **脊髓电刺激(SCS)**: 适用于带状疱疹后神经痛、CRPS、周围神经损伤等 [P5]
12. **糖皮质激素**: 有抗炎和免疫抑制作用, 可用于多种疼痛, 但需严格掌握适应证 [P5]
13. **加巴喷丁/普瑞巴林**: 主要用于神经病理性疼痛 [P5]
14. **肌肉注射镇痛**: 因血药浓度波动大, 现已很少用于术后镇痛 [P3]

七、考点速记

- **2020 IASP疼痛定义**: 增加了"或与此相似的经历" [P1]
- **NRS**: 0~10分, 4~6=中度, 7~10=重度 [P1]
- **FPS-R**: 面部表情评分, 儿童/老年/表达困难者首选 [P1]
- **VAS**: 科研最常用, 100mm直线 [P1]
- **伤害感受性疼痛** = 组织损伤 + 炎性因子刺激 [P2]
- **神经病理性疼痛** = 感觉系统损害 + 外周敏化 + 中枢敏化 [P2]
- **中枢敏化** → 自发性疼痛、痛觉过敏、痛觉超敏 [P2]
- **术后疼痛管理支柱**: 阿片类药物 + 多模式镇痛 [P3]
- **NSAIDs**: 非选择性→胃肠道损伤; COX-2选择性→胃肠道损伤少 [P3]
- **多模式镇痛**: 不同机制药物/技术联合, 围手术期最常用 [P3]
- **APS**: 急性疼痛服务小组, 多学科管理 [P3]
- **慢性疼痛**: >3个月, 7种分类 [P4]
- **神经阻滞用药**: 局麻药 + 糖皮质激素 ± 神经毁损药 [P5]
- **SCS**: 脊髓电刺激, 神经调控一线方法 [P5]
- **IDDS**: 鞘内药物输注系统, 癌痛及难治性疼痛 [P5]
- **WHO三阶梯**: 按阶梯、口服、按时、个体化、注意细节 [P6]
- **癌痛**: 肿瘤本身+抗肿瘤治疗均可引起 [P6]
- **慢性疼痛一线用药**: NSAIDs(轻)、阿片类口服(中重度) [P5]
- **神经病理性疼痛**: 加巴喷丁/普瑞巴林/曲马多 [P5]
- **右美托咪定**: 增加心动过缓及呼吸抑制风险 [P3]